

PATOLOGÍA MAMARIA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

Maria Berdeal Diaz

INTRODUCCIÓN

En este capítulo tratamos de exponer los motivos de consulta más habituales, con el objetivo de conocer el manejo inicial, su diagnóstico diferencial y establecer criterios de derivación a consultas especializadas.

Las causas de consulta son:

- Dolor mamario.
- Nódulo palpable.
- Secreción mamaria.
- Lesiones cutáneas.
- Traumatismos mamarios.
- Otras (seroma, hematomas, extrusión de prótesis).

Dolor mamario

Causa más frecuente de consulta.

- Dolor mamario cíclico o mastodinia (67%): mujeres de edad fértil, suele aparecer en alguna fase del ciclo menstrual, bilateral.
- Dolor mamario no cíclico o mastalgia (23%): continuo y habitualmente unilateral. Puede deberse a un proceso inflamatorio, fibroadenomas, quistes de crecimiento rápido...

Diagnóstico diferencial

DOLOR MAMARIO	MUSCULO-ESQUELÉTICO	DOLOR REFERIDO	OTROS
• Mastodinia • Mastitis • Traumatismos mamarios • Enfermedad de Mondor • Quistes • Ginecomastia • Contractura capsular (portadoras de prótesis mamarias) • Postquirúrgico (neuromas, mama fantasma...) • Tumores benignos • Cáncer	• Dolor de pared costal • Costocondritis • Fracturas costales • Síndrome TIETZE (inflamación entre el 2º y 3º cartílago intercostal) • Fibromialgia • Radiculopatía cervical	• Enfermedad coronaria • Pericarditis • Tromboembolismo pulmonar • Pleuritis • Reflujo gastroesofágico • Úlcera gastroduodenal	• Psicológico • Herpes zoster • Fármacos: -Tratamientos hormonales. -Antidepresivos. -Antipsicóticos. -Antihipertensivos, tratamientos cardiológicos (digoxina). -Antibióticos, antifúngicos. -Otros (ciclosporina, domperidona, metadona).

Anamnesis

Características del dolor, localización (uni/bilateral), duración, irradiación, intensidad, forma de aparición, tiempo de evolución, factores que lo exacerben o lo desencadenen, relación con los ciclos menstruales, cirugías previas, traumatismos previos, ingesta de fármacos.

Exploración física

Valorar si existen signos inflamatorios, deformidades, cicatrices, lesiones cutáneas, nódulos palpables, adenopatías axilares, escoliosis o cifosis, lesiones en la pared costal o dolor a la palpación.

Pruebas complementarias

- Ecografía mamaria: mastitis ,absceso mamario, hematoma.
- Rx tórax y parrilla costal: sospecha de fracturas costales, costocondritis.
- Rx columna cervical y dorsal: radiculopatías.

Tratamiento

Iniciar tratamiento específico en aquellos casos de dolor extramamario.

Tratamiento sintomático para el dolor

La mayoría de casos se **derivarán a una consulta especializada** de patología mamaria, para completar estudios.

MASTITIS

Clasificación

MASTITIS INFECCIOSAS	• A- Simple: 1. Purulenta. 2. No purulenta • B- Complicada: 1. Absceso. 2. Fistulizante. 3. Quiste infectado 4. Galactocele infectado. 5. Seroma o colección postquirúrgica infectada • C- Mastitis específicas: 1. Mastitis tuberculosa 2. Mastitis fungica
MASTITIS NO INFECCIOSAS	• A- Mastitis primarias de la mama: 1. Mastitis periductal o Ectasia ductal 2. Mastitis granulomatosa idiopática 3. Pseudotumor inflamatorio • B- Mastitis secundarias: 1. Postradioterapia: Mastitis r�dica 2. Postraum�tica: Necrosis grasa 3. Secundaria a cuerpo extra�o: siliconomas 4. Secundarias a patolog�a sist�mica: • Mastopat�a diab�tica • Mastitis l�pica • Amiloidosis • Sarcoidosis • Vasculitis
PATOLOG�A MALIGNA	• A. Carcinoma inflamatorio • B. Tumores de mama abscesificados

MASTITIS INFECCIOSA SIMPLE

El *S. aureus* es el agente causal m s frecuente de las mastitis infecciosas (75%). Otros agentes pueden ser *Streptococo*, enterobacterias, levaduras.

Cl nica: Dolor intenso de la mama con signos inflamatorios (enrojecimiento, tumefacci n e induraci n). Puede acompa arse de fiebre, mialgias, escalofr os y malestar general (m s

frecuente en las mastitis puerperales) y adenopatías axilares.

Diagnóstico Clínico

Es necesario realizar una **ECOGRAFÍA** para descartar un absceso subyacente y un **ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO** de la leche (puerperales) y de la secreción mamaria (no puerperales).

- **Puerperal:** Es la forma más común de mastitis infecciosas. Ocurren durante la lactancia. Pueden ser uni o bilaterales. Los principales factores predisponentes son la ingurgitación y obstrucción de un conducto lácteo, la presencia de grietas en el pezón o una mala técnica de lactancia.
 - **Tratamiento:** Vaciamiento eficaz de la leche. Aplicar compresas tibias.
 - **Analgésicos, antiinflamatorios y antibiótico:** Ciprofloxacino 750mg/12h durante 14 días o Trimetropin-Sulfametoxazol 160/800/12h durante 14 días. En pacientes alérgicas se puede emplear Cloxacilina o Eritromicina. Puede **mantenerse la lactancia**.
- **No puerperal:** Son menos frecuentes. Los factores predisponentes son infecciones de las glándulas de Montgomery, heridas, eccema...
 - **Tratamiento:** analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos: Amoxicilina/Clavulámico o eritromicina+metronidazol en pacientes alérgicas.
 - **Remitir a consulta especializada** para valoración. En caso de mala respuesta tras 1 semana de tratamiento se realizarán estudios diagnósticos para poder establecer el diagnóstico diferencial con un carcinoma inflamatorio u otras causas de mastitis no infecciosa.

MASTITIS INFECCIOSA COMPLICADA

- **Absceso mamario:** Se considera una urgencia quirúrgica, es preciso evacuarlo y tomar una muestra para cultivo. **Avisar a CIRUGÍA DE GUARDIA.**

Nódulo palpable

Motivo de consulta muy frecuente. Se necesitarán estudios complementarios específicos para el diagnóstico. **Remitir a consulta especializada con carácter muy preferente** si nódulo de reciente aparición, crecimiento rápido, de consistencia dura, irregular, fijo a planos profundos o que provoque retracción cutánea

Secreción mamaria

En el 95% de los casos es secundaria a procesos benignos. Por sus características diferenciamos:

- **Galactorrea:** secreción láctea no fisiológica, es bilateral y secundaria a procesos funcionales (hiperprolactinemia, fármacos, estrés...)
- **Telorreya:** líquido más o menos denso, que puede ser claro u oscuro, uni o bilateral y por uno o múltiples orificios. Puede tratarse de procesos funcionales o procesos orgánicos (papilomas y los adenomas del pezón)
- **Telorrágica:** la secreción sanguinolenta uniorificial y unilateral debe hacernos sospechar en un proceso tumoral.

Remitir a consulta especializada con carácter muy preferente si existe telorrágica, secreción uniorificial, unilateral y espontánea o si asocia un nódulo palpable.

Lesiones cutáneas

DERMATOSIS ESPECÍFICAS DE LA MAMA (poco frecuentes)

- Enfermedad de Paget del pezón: lesión eczematososa o erosiva que afecta a la piel de la areola y/o el pezón. No responde a tratamiento con corticoides. El diagnóstico es anatómico-patológico. Se asocia a un carcinoma subyacente en 87% de casos.
- **Remitir a consulta especializada con carácter muy preferente.**
- Adenomatosis erosiva del pezón: es una lesión benigna que simula la Enfermedad de Paget.

DERMATOSIS NO ESPECÍFICAS (frecuentes)

- **Eccema:** lesión muy prevalente que se caracteriza por eritema, descamación y prurito asociado. Afecta generalmente al complejo areola pezón. Tratamiento: corticoides tópicos.
- **Intertrigo submamario:** lesiones eritematosas en surco submamario.
 - Intertrigo candidiásico: pústulas satélite. Tratamiento: imidazólicos.
 - Intertrigo psoriásico. Tratamiento: corticoides tópicos.
 - Intertrigo irritativo. Tratamiento: corticoides tópicos.
- **Hidradenitis supurativa.** Tratamiento: drenaje quirúrgico en lesiones muy inflamadas y dolorosas. Tetraciclinas reducir la inflamación asociada.
- **Herpes zoster o herpes simple.** Tratamiento: valaciclovir 1gr/8h 7 días(Herpes zoster)y 500 mg/12h 5 días(Herpes simple)
- **El herpes zoster** si no se trata en las primeras 72 horas presenta mayor riesgo de neuralgia postherpética.
- **Escabiosis:** afecta típicamente a la zona periareolar en las mujeres. Buscar lesiones similares pruriginosas a nivel genital, en manos y pies.

Traumatismos mamarios:

- **Traumatismos penetrantes:** pueden asociar lesiones torácicas (fracturas costales, hemoneumotórax, taponamiento pericárdico)
- **Traumatismos cerrados:** 98% por accidentes de tráfico-colisión. Puede asociar lesiones intrabdominales (desgarros mesentéricos), fracturas de clavícula, esternón, costillas, vértebras, extremidades...

		SÍNTOMAS / SIGNOS	TRATAMIENTO
I	LESIÓN LEVE APLASTAMIENTO	• Equimosis / ampolla	• Analgesia+ Observación
II	LESIÓN MODERADA APLASTAMIENTO	• Hematoma / Necrosis grasa afectación cutánea laceraciones	• Sutura • Drenaje hematoma • Ecografía mamaria
III	LESIÓN SEVERA APLASTAMIENTO	• Transección parcial/completa • Hendidura mamaria diagonal	• Tratamiento quirúrgico
IV	LESIÓN AVULSIÓN	• Avulsión parcial/completa sangrado activo	• TAC Torácico • Angiografía embolización Cirugía.

Clasificación de traumatismos mamarios (MAJESKI). **Avisar a CIRUGÍA DE GUARDIA** en traumatismos severos (III-IV)

Otras

- Complicaciones postquirúrgicas: Seroma, sangrado, hematoma, dehiscencia de suturas, extrusión de prótesis. En estos casos es necesario **avisar a CIRUGÍA DE GUARDIA** para

valoración.

BIBLIOGRAFÍA

- Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria. Manual de Práctica Clínica en Senología. 4ª ed. Madrid: Fundación Española de senología y Patología Mamaria; 2019.
- Parrilla Paricio P, Landa García JI. Manual de Cirugía de la AEC. 2ª ed. Médica Panamericana:Madrid;2010.
- Majeski J. Shoulder restraint injury of the female breast. Int Surg. 2007;92(2):99-102.